

Obstrucción intestinal

1. Introducción y relevancia clínica

La **obstrucción intestinal (OI)** se define como la **interrupción total o parcial del tránsito del contenido intestinal**. Puede afectar el intestino **delgado** o **grueso**, y su importancia clínica radica en que constituye una **emergencia quirúrgica** potencialmente letal si no se reconoce y trata a tiempo.

En Chile y Latinoamérica, las **principales causas** son:

- **Adherencias postoperatorias (60–70%)**
- **Hernias encarceladas o estranguladas (10–15%)**
- **Tumores (10–15%)**
- **Vólvulo, intususcepción, enfermedad inflamatoria intestinal y cuerpos extraños**

La **mortalidad** global es baja (<5%) en obstrucciones simples tratadas precozmente, pero puede llegar al **20–40%** si se complica con **isquemia, necrosis o perforación**.

Por eso, el **objetivo principal** es diferenciar rápidamente una **obstrucción simple (sin isquemia)** de una **complicada (con sufrimiento intestinal)**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Clasificación general

Tipo	Descripción	Ejemplo
Mecánica	Obstrucción física del lumen	Adherencias, hernia, tumor, vólvulo
Funcional (íleo paralítico)	Falta de motilidad sin causa obstructiva	Postoperatorio, peritonitis, fármacos, sepsis

Por localización	Alta (intestino delgado) o baja (colon)	Íleon distal vs sigmoides
Por grado	Parcial o completa	Según paso de gas/líquidos

2.2 Fisiopatología de la obstrucción mecánica

- El **aumento de la presión intraluminal** produce:
 - **Distensión intestinal**, acúmulo de gas y líquido.
 - **Compromiso del retorno venoso** → edema → **isquemia**.
 - Si persiste: **necrosis, perforación, peritonitis**.
 - Se pierden grandes volúmenes de líquido y electrolitos hacia el lumen ("**tercer espacio**").
 - **Hipovolemia, alcalosis metabólica e hipocloremia** (si vómitos), o acidosis (si necrosis).
-

2.3 Fisiopatología del íleo paralítico

- No existe obstrucción mecánica; el intestino está **adínamico**.
 - Causas: **cirugía abdominal reciente**, trauma, fármacos (opiáceos, anticolinérgicos), sepsis, alteraciones hidroelectrolíticas.
 - Suele ser **autolimitado** (2–3 días).
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Cuadro clínico típico

Depende del nivel y la causa, pero el patrón clásico es:

Síntoma	Intestino delgado	Colon
Dolor abdominal tipo cólico	Intenso, intermitente, periumbilical	Menos cólico, progresivo
Distensión abdominal	Moderada	Marcada
Vómitos	Precoces y frecuentes	Tardíos o ausentes
Ausencia de eliminación	De gases y heces	De gases al inicio, heces después
Ruidos intestinales	Aumentados al inicio (“de lucha”)	Disminuyen con isquemia o íleo

Fases evolutivas:

1. **Distensión y cólicos** por aumento del peristaltismo.
2. **Vómitos** y deshidratación progresiva.
3. **Silencio abdominal** si hay sufrimiento o necrosis.

3.2 Signos de alarma (obstrucción complicada)

- Fiebre, taquicardia, hipotensión.
- Dolor abdominal **continuo e intenso (no cólico)**.
- **Defensa o rebote** → irritación peritoneal.
- **Leucocitosis >15.000** o acidosis metabólica.
- **Aumento de lactato plasmático** (sufrimiento intestinal).

- **Aire libre** o líquido libre en TAC.

□ Estos signos indican **isquemia o necrosis intestinal**, y requieren cirugía inmediata.

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferenciación clave
Íleo paralítico	Dolor leve, ruidos ausentes, TAC sin obstáculo
Gastroenteritis	Diarrea, fiebre, sin distensión marcada
Perforación viscera hueca	Aire libre subdiafragmático
Isquemia mesentérica aguda	Dolor desproporcionado, lactato alto
Pseudobstrucción colónica (Ogilvie)	Colon dilatado sin obstrucción mecánica

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Laboratorio

- **Hemograma:** leucocitosis (infección o necrosis).
- **Electrolitos:** hipocloremia, alcalosis metabólica.
- **Urea/creatinina:** deshidratación.
- **Lactato plasmático:** elevado si isquemia intestinal.
- **PCR:** orienta a inflamación o perforación.

4.2 Imágenes

A. Radiografía simple de abdomen (de pie y decúbito)

- **Primer examen** en urgencias.
- Hallazgos:
 - Distensión de asas intestinales.
 - **Niveles hidroaéreos escalonados.**
 - **Ausencia de gas distal.**
 - “Arcos concéntricos” o “pilas de monedas” (delgado).
 - **Haustras gruesas, separadas** (colon).

En obstrucción completa: ausencia total de gas rectal.

B. TAC abdominopélvico con contraste (gold standard)

- Sensibilidad >95%.
- Permite **confirmar obstrucción, determinar nivel, causa y gravedad.**
- Signos:
 - Asas dilatadas >2,5 cm (delgado) o >6 cm (colon).
 - “Punto de transición” (lugar de obstrucción).
 - Grasa mesentérica aumentada, líquido libre (isquemia).
 - “Whirl sign” (vólvulo).
 - Aire extraluminal (perforación).

C. Otros

- **Ecografía:** útil en niños o embarazo.
 - **Colon por enema con contraste hidrosoluble:** diagnóstico y terapéutico en vólvulo de sigmoides.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL y WSES 2021)

5.1 Objetivos

1. Corregir la **hipovolemia** y los trastornos electrolíticos.
 2. Descomprimir el intestino.
 3. Tratar la causa y prevenir la necrosis.
-

5.2 Manejo inicial (todos los pacientes)

- **Hospitalización inmediata.**
 - **Ayuno estricto.**
 - **Reposición de volumen:**
 - Cristaloides (Ringer lactato o SF 0,9%).
 - Monitoreo de diuresis ($>0,5$ mL/kg/h).
 - **Sonda nasogástrica (SNG):**
 - Descompresión, reduce vómitos y riesgo de aspiración.
 - **Sonda vesical:** monitorización de diuresis.
 - **Antieméticos y analgesia.**
 - **Antibióticos:** solo si sospecha de isquemia o perforación.
 - Ceftriaxona + Metronidazol o Piperacilina/Tazobactam.
-

5.3 Conducta según tipo y evolución

A. Obstrucción intestinal simple (sin signos de isquemia)

- **Tratamiento conservador** inicial (24–48 h):
 - Hidratación + SNG + observación clínica.
 - Si mejoría → reintroducir alimentación progresiva.
- **Fracaso del manejo médico** (sin paso de gas, dolor persistente o distensión progresiva) → cirugía.

B. Obstrucción complicada (con isquemia, perforación o estrangulación)

- **Cirugía urgente.**
- Procedimiento:
 - **Exploración laparotómica o laparoscópica.**
 - Resección de asas necróticas.
 - Liberación de adherencias o reparación de hernia.
 - Lavado y drenaje si hay contaminación.

C. Causas específicas

Causa	Tratamiento
Adherencias	Conservador; cirugía si no mejora o hay isquemia
Hernia estrangulada	Reducción quirúrgica urgente
Vólvulo de sigmoides	Descompresión endoscópica; si recidiva → sigmoidectomía
Tumor colónico	Resección; derivación si obstrucción completa

Íleo paralítico Tratar causa subyacente (electrolitos, sepsis, fármacos)

5.4 Indicaciones absolutas de cirugía urgente

- Signos de **peritonitis**.
 - **Isquemia intestinal** (dolor continuo, lactato alto).
 - **Neumoperitoneo**.
 - **Falla del manejo conservador >48 h**.
 - **Obstrucción completa sin mejoría**.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Consecuencia
Isquemia y necrosis intestinal	Por compromiso vascular	Sepsis, perforación
Perforación y peritonitis	Ruptura del asa	Shock séptico
Sepsis intraabdominal	Por necrosis o contaminación	Alta mortalidad
Insuficiencia renal aguda	Hipovolemia severa	Requiere reanimación
Síndrome compartimental abdominal	Por distensión y fluidos excesivos	Hipoperfusión visceral

Pronóstico:

- Mortalidad <5% en casos simples tratados precozmente.
 - Hasta 40% en necrosis intestinal o sepsis.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Dolor cólico + distensión + vómitos + ausencia de eliminación** = pensar en OI hasta demostrar lo contrario.
 2. **Radiografía simple** es el examen inicial, pero **TAC con contraste** es el **gold standard**.
 3. **Sonda nasogástrica y fluidoterapia** son medidas iniciales obligadas.
 4. Si hay **signos de sufrimiento intestinal (dolor continuo, fiebre, lactato alto)** → **cirugía inmediata**.
 5. La causa más frecuente de obstrucción delgado: **adherencias postoperatorias**.
 6. En **vólvulo de sigmoides**, intentar **descompresión endoscópica inicial**.
 7. **No retrasar cirugía >48 h** si no hay resolución con manejo médico.
-



Errores comunes

- Confundir **íleo paralítico postoperatorio** con obstrucción mecánica.
- Omitir **TAC** cuando la radiografía es equívoca.
- Administrar líquidos insuficientes o no corregir electrolitos.
- Dejar al paciente **más de 2 días en manejo conservador** sin reevaluación quirúrgica.

- No usar antibióticos ante signos de necrosis o fiebre alta.
 - Pasar por alto hernias pequeñas incarceradas como causa de OI.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **obstrucción intestinal** es una urgencia quirúrgica por **interrupción del tránsito**; puede ser **mecánica o funcional (íleo)**.
2. Causas más frecuentes: **adherencias, hernias, tumores**.
3. Clínica cardinal: **dolor cólico, vómitos, distensión y ausencia de gases/heces**.
4. **TAC con contraste** es el **gold standard** para confirmar diagnóstico y definir nivel/causa.
5. Manejo inicial: **reposición de volumen + SNG + ayuno + monitoreo**.
6. **Cirugía urgente** si hay signos de isquemia, peritonitis o falla del manejo médico en 24–48 h.
7. **Pronóstico excelente** si se diagnostica y maneja precozmente; mortalidad elevada en necrosis intestinal.